PERFORATIONS OESOPHAGIENNES EN PRATIQUE ORL, AU CHU SOURÔ SANOU DE BOBO DIOULASSO

Nom du présentateur : ***OUEDRAOGO RW-L***

Auteurs et coauteurs : ***OUEDRAOGO RW-L,*** *OUEDRAOGO NLM, DIAKITE S, DIESSONGO N, SANOU M, ELOLA A*

Affiliations : CHU SOURÔ SANOU

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Discussion
- Conclusion

Objectif

Etudier les aspects **épidémiologiques**, **diagnostiques** et **thérapeutiques** dans notre contexte

Introduction

Perforation œsophagienne = Interruption de la continuité pariétale de l'œsophage

-**Complication redoutable** de la pathologie œsophagienne, touchant surtout les sujets jeunes

-Pose un problème de **PEC et de Pronostic** dans notre contexte de limite thérapeutique

Matériel et méthode(s)

- **Etude:** Rétrospective de type descriptif (20ans), de 2005 – 2024

- **Services:** ORL et Chirurgie Cervico-Faciale du CHU Sourô SANOU

- **Mode :** Recensement (tout cas de perforation œsophagienne pris en charge pendant la période)

- **Sources de données:** Dossiers cliniques, Registres d'hospitalisation et de Compte Rendu Op

Résultats

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

- **Fréquence** = **54 cas**/20 ans (02,7cas/an)
- **Age moyen** = **18,12 ans** +/- 7,2 , **[0-20ans[**=(51,8%)
- **Sex ratio** = **2,37**
- **Délai moyen** de diagnostic = **01,2 mois** [01 Jour - 17mois]
- **Antécédents** = -Œsophagites **caustiques:** 18 cas (33,33%)
  -Œsophagites **peptiques:** 04cas (07,41%)

Résultats

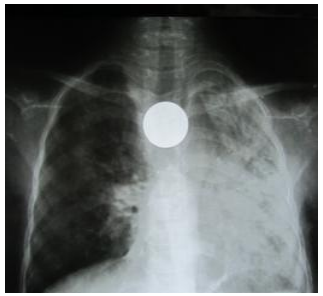
❑ DONNEES DIAGNOSTIQUES

➢ **Circonstances de découverte** =

- **Douleur** thoracique: 32 cas(59,26%)
- **Toux** per-prandiale: 31 cas (57,40%)
- **Dysphagie**: 29cas (53,70%)

➢ **Moyens diagnostiques** =

- **Arguments Cliniques et Radio:** (100%),
- **Endoscopie**(38,88%)



➢ **Tableau clinique** =

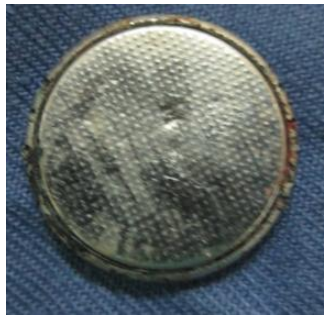
- **Broncho-pneumopathie**: 27 cas (50%),
- **Emphysème** cervico-thoracique:12 cas (22,22%)
- Médiastinite: 09 cas (16,66%),
- Péritonite: 03 cas (05,55%)

Résultats

❑ DONNÉES DIAGNOSTIQUES

➢ **Topographie (Perforation)** = -Cervicale: 14cas (25,92%)
-**Thoracique**: 36 cas (66,66%)
-Abdominale: 04cas (07,40%)

➢ **Facteurs étiologiques** = -**Corps étrangers**: 34 cas (62,96%)
-Endoscopies: 12cas (22,22%)
-Œsophagites corrosives: 06 cas (11,11%)
-Tumeurs œsophagiennes: 02cas (08,70%)



Résultats

❑ DONNÉES THÉRAPEUTIQUES

➢ **Moyens thérapeutiques** = **-Soins d'Urgence:** ATB thérapie(100%) + Réa (27,7%)

-Recup nutritionnelle: SNG: 43(79,62%) + Stomie: 11(20,37%)

-Réparation pariétale: Raphie 04(07,4%) + Plastie 03(05,55%)

➢ **Durée moyenne de soins** = 72,27 +/- 17 jours [23 - 112 jours]

➢ **Evolution post-thérapeutique** = **-Favorable** (récupération intégrale): 28 cas **(51,85%)**

-Complications infectieuses:17(31,48%)+**respiratoires:** 09(16,67%)

-Létalité = 24cas **(48,15 %)**

Discussion

❑ ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

➢ **Incidence = 02,7 cas/an:** ***Relative rareté.***

*-Néanmoins **suffisante**, pour une attention particulière (Gravité)*

➢ **Age moyen = 18 ans, [0-20[** (51,8%): ***Pathologie à connotation pédiatrique***

-Fragilité pariétale

-Origine principalement accidentelle *des pathologies pourvoyeuses*

➢ ***Sex ratio*** **= 2,37:** *Prédominance masculine*

-Turbulence du garçon + Plus grande liberté *(risque élevé des facteurs etiologiques)*

Discussion

❑ ASPECTS DIAGNOSTIQUES

➢ **Diagnostic = Principalement Clinico-Radiographique** (100%) *(D BASTIAN 2002)*

*-**Présomption clinique** (Douleur + Dysphagie + Toux)*

*-**Confirmation Rx (TOGD):** Evidence Perforation + Topographie*

➢ **Topographie** (Perforation) = **Majoritairement thoracique++**

-Longueur + Nombre de rétrécissements plus importants

(Perforation intra-thoracique = plus morbide et moins accessible a la PEC)

➢ **Facteurs étiologiques = Corps étrangers 0** (62,96%) + **Endoscopies** (22,22%)

-Origine traumatique + Survenue accidentelle + Prévention accessible

Discussion

❑ ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

➢ **Prise en charge = Médico-chirurgicale** *(JN Maillard 2008)*

-***Pronostic vital*** *(Antibiothérapie + Réanimation médicale+++)*

-***Continuité nutritionnelle*** *(Sondage NG + Stomies)*

-***Réparation lésionnelle*** *(Raphies et plasties)= exceptionnelle*

➢ **Evolution** = Taux de **létalité** (48,15%): **Haute mortalité**

-***Précarité sanitaire*** *préalable des patients concernés*

-***Fréquence élevée des complications*** *infectieuses et respiratoires inhérentes*

➢ *Intérêt de lutter* ***contre les facteurs étiologiques*** *pourvoyeurs de cette complication œsophagienne*

Conclusion

- Perforation œsophagienne = **Urgence** médico-chirurgicale **accidentelle**++
- Diagnostic = Principalement **clinico-radiographique** (TOGD++)
- PEC= **Symptomatique** (Pronostic vital + nutritionnel), avec un taux de **mortalité élevé** DNC
- Importance des **Mesures préventives** (**Sensibilisation** + **Surveillance** + **Soins** adaptés)

Merci pour votre attention